



LES PLEURÉSIES PURULENTES

Dr A. Alioua

Maitre assistante en pneumophtisiologie
Centre hospitalo-universitaire de Constantine

OBJECTIF

- ❑ Définir une pleurésie purulente
- ❑ Décrire les stades évolutifs des pleurésies purulentes
- ❑ Décrire les principales complications des pleurésies purulentes
- ❑ Décrire la conduite à tenir devant une pleurésie purulente

PLAN

- I. Définition
- II. Intérêt de la question
- III. Anatomie pathologie
- IV. Pathogénie
- V. Diagnostic positif
- VI. Diagnostic Etiologique
- VII. Traitement
- VIII. Evolution
- IX. Conclusion

I. DÉFINITION

C'est la présence dans la cavité pleurale d'un liquide d'aspect louche, trouble, ou franchement purulent, contenant une majorité des polynucléaires neutrophiles (PN) altérés (Empyème)

II. INTÉRÊT DE LA QUESTION

- ❑ Les pleurésies purulentes compliquent l'évolution d'environ 2 à 5 % des pneumonies
- ❑ Une urgence thérapeutique
- ❑ Problème diagnostic bactériologique et thérapeutique
- ❑ Gravité: terrain sous-jacent

III. ANATOMIE PATHOLOGIE

La pleurésie purulente passe par trois phases:

1- Phase exsudative

2. Phase de collection

3- Phase d'enkystement

STADE I :Stade exsudatif

Phase exsudative



- ▶ Les feuillets viscéral et pariétal sont encore mince, très congestifs, de couleur rougeâtre.
- ▶ Le liquide citrin, +/- louche
- ▶ La lésion pulmonaire sous-jacente est en pleine évolution.
- ▶ A ce stade, **la guérison anatomique totale** est encore possible sous l'effet du seul traitement médical. L'épanchement se résorbe, la réexpansion pulmonaire se fera sans séquelles.

III. ANATOMIE PATHOLOGIQUE

2- Phase de collection

- Liquide franchement purulent et plus épais.
- Les deux plèvres qui sont épaissies, rigides.
- Cloisonnement rapide avec accumulation dans la partie postéro-inférieure.

Stade II: fibrino-purulent



Epanchement pleural cloisonné
(vidéo-thoracoscopie)



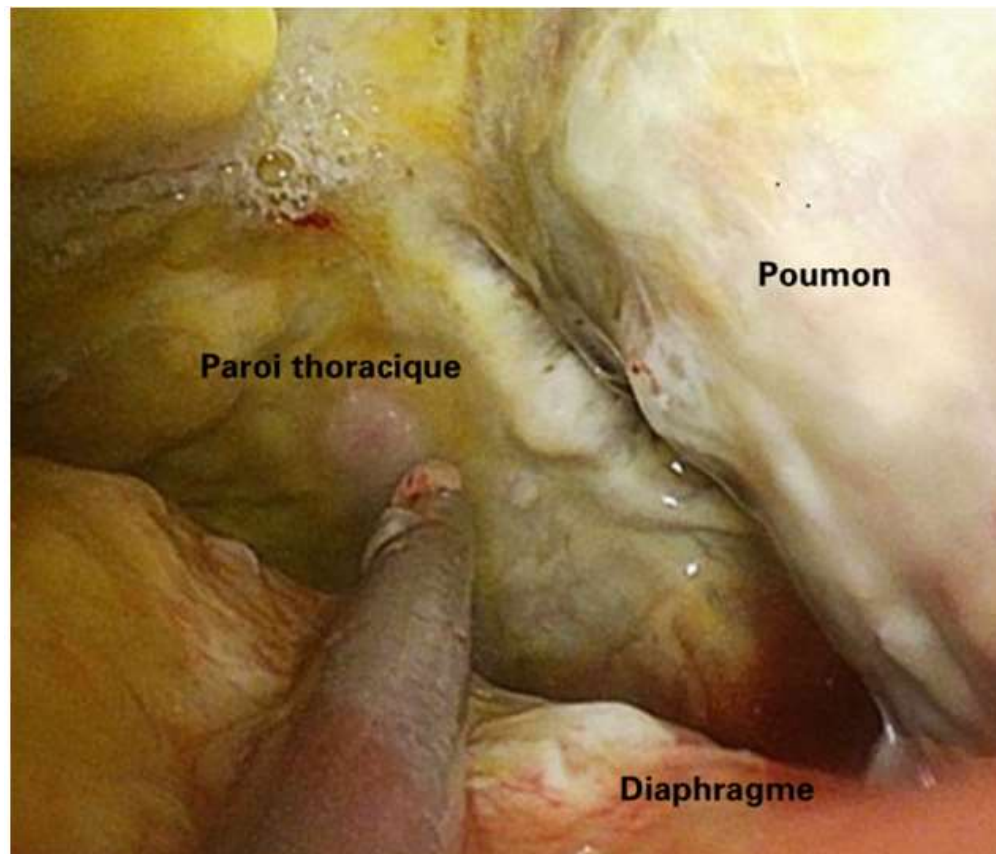
Cloisonnement
à l'échographie transthoracique

III. ANATOMIE PATHOLOGIQUE

3- Phase d'enkystement

- Liquide purulent, enkysté par la symphyse pleurale.
- Plèvre sclérosée (pachypleurite) avec accolement des 2 feuillets
limitant un poumon trapé (traped lung)
- Lésions souvent irréversibles.

**Stade III: Stade d'enkystement
poumon recouvert de tissu conjonctif et de fibrine.**



Mode d'évolution d'une pleurésie purulente

Phase exsudative



Phase de collection



Phase d'enkystement



IV. PATHOGÉNIE

1 -Facteurs favorisants

A -Généraux

- Tabagisme/Ethylisme
- Diabète
- Dénutrition
- Immunodépression
- Troubles de déglutition

B -Foyer de porte d'entrée

- Orl /Mauvaise hygiène buccodentaire/Sinusite infectieuse
- Cutanée
- Obstruction bronchique

IV. PATHOGÉNIE

2- Mécanisme de survenue

- Pleurésie purulente secondaire à un foyer septique pulmonaire :
 - pneumonie, abcès, DDB suppurée

- Pleurésie purulente par inoculation directe:
 - Plaie pénétrante
 - Ponction / biopsie iatrogène
 - Post-thoracotomie

- Pleurésie purulente par inoculation indirecte:
 - Fistule bronchique
 - Fistule œsophagienne
 - abcès sous phrénique
 - Abcès hépatique

- Voie hématogène (Endocardite infectieuse)

V. DIAGNOSTIC POSITIF

1- Clinique:

- Le début brutal++
- un syndrome infectieux + altération importante de l'état général
 - Fièvre élevée avec frissons.
 - Douleurs thoraciques
 - Toux sèche
 - dyspnée parfois cyanose.

❑ Examen physique : **Trépied de Trousseau**

- Inspection : immobilité relative d'un héli thorax –
- Palpation : diminution ou abolition des vibrations vocales
- Percussion : une matité franche, déclive.
- Auscultation : diminution ou abolition du murmure vésiculaire

❑ L'examen doit être compléter par l'examen de la cavité buccale et la
sphère ORL

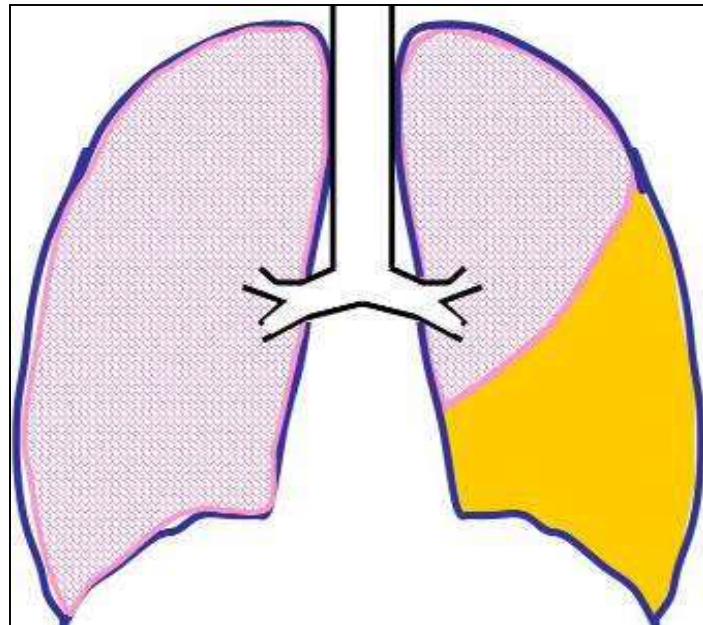
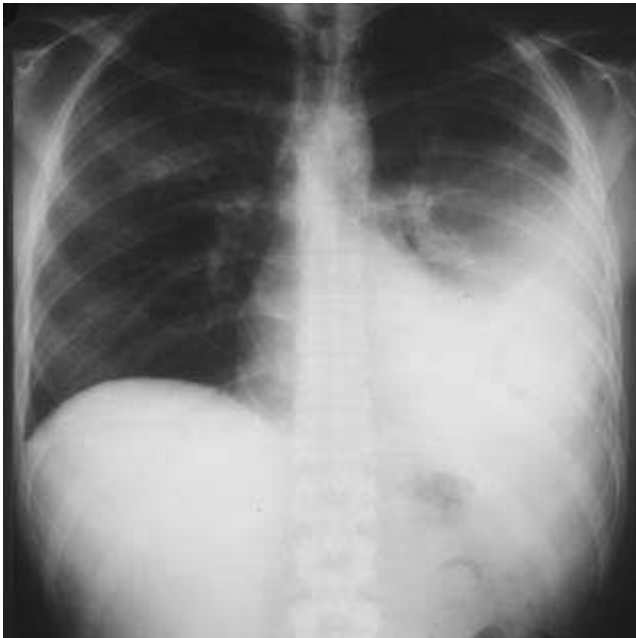
2- Examens paraclinique

A- Radio du thorax F/P:

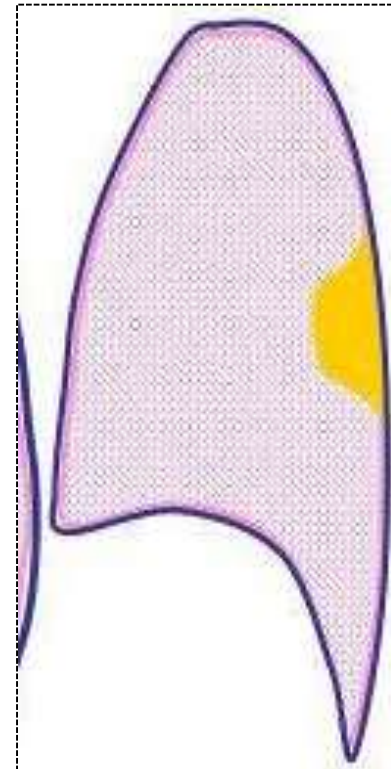
En fonction du stade en aura

- **Stade de diffusion:** image d'un épanchement pleural libre à limite supérieure concave en haut et en dedans
- **Stade de collection:** opacité en forme de ménisque basithoracique axillaire ou postérieure
- La présence de niveau liquide évoque des germes anaérobies ou une fistule.

Pleurésie libre



Pleurésie enkystée



B- Echographie thoracique:

De plus en plus utilisée ++

- Faire le diagnostic et apprécier la nature de l'épanchement
(cloisonnement)
- Guider la ponction pleurale et le drainage thoracique

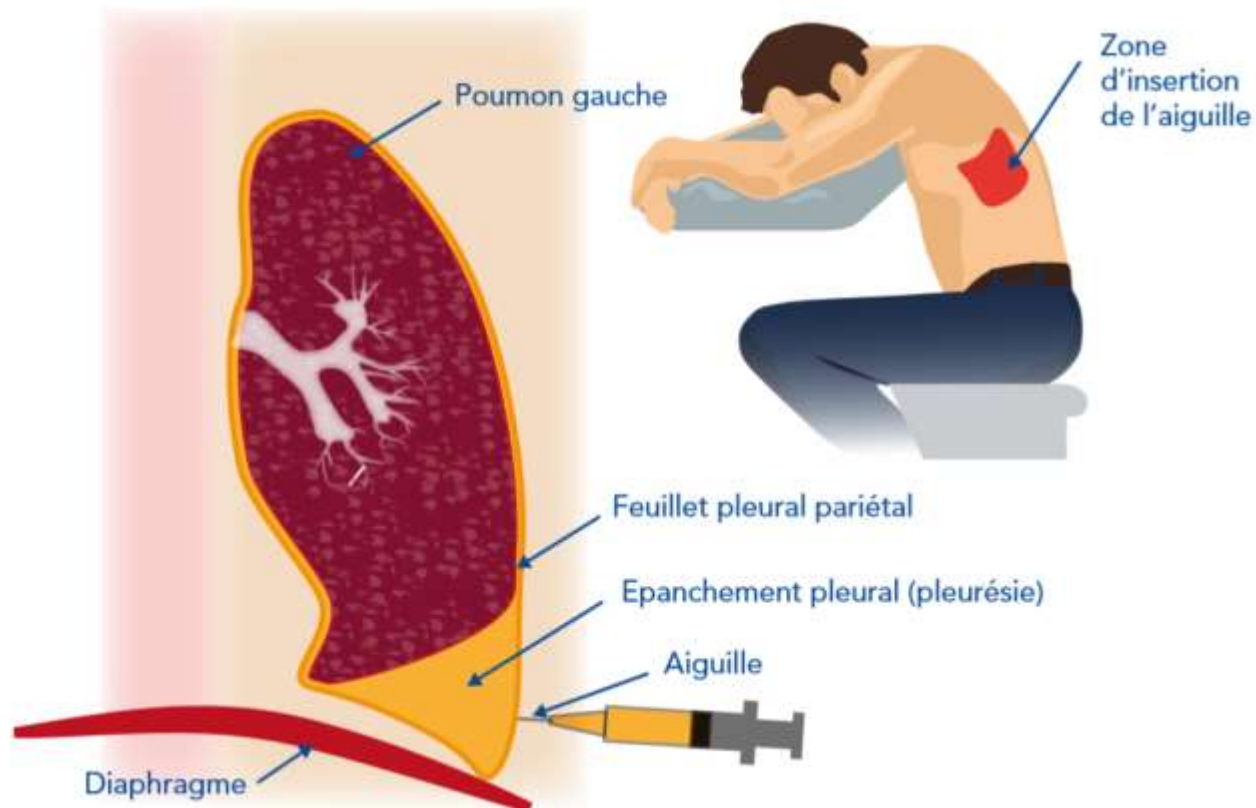
C- Ponction pleurale : Examen clé ++

La ponction pleurale confirme le diagnostic

Effectuée avant toute antibiothérapie avec une aiguille de calibre suffisant.

S'effectue en pleine matité

PONCTION PLEURALE



Macroscopie: un liquide louche ou purulent ,épais,
parfois fétide (anaérobies)

Etude biochimique: au stade de purulence

- **exsudatif**
- $\text{PH} < 7,20$
- Taux de LDH $> 1000 \text{ u/l}$
- Glycopleurie $< 0,4\text{g/l}$

Etude cytologique: prédominance de **PNN altérés**.

Etudes bactériologique:

- Examen direct et culture (aérobie et anaérobie)
- Recherche des BK par examen direct et culture
- Antibiogramme

**Liquide pleural
d'aspect purulent**



PONCTION PLEURALE

D- BILAN GÉNÉRAL

Biologie

- FNS: Hyperleucocytose à PNN
- CRP élevée
- Hémocultures
- ECB de l'expectoration, prélèvements endobronchiques protégés
- Bilan selon le Terrain: diabète , insuffisance rénale , sérologie

Autres

- Prélèvement au niveau d'une porte d'entrée
- TDM thoracique : Topographie /rechercher un foyer parenchymateux.
- Echographie abdomino-pelvienne
- Fibroscopie : rechercher une cause locale
- EFR et gazométrie: évaluation de retentissement

VI. DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

Selon le germe

1-Pneumocoque:

- Pneumopathie sous-jacente quasi constante
- Tendance au cloisonnement très rapide..

2 - Streptocoque:

- Chercher surtout un foyer ORL, cutané ou dentaire

3- Staphylocoque:

- Terrain :Diabète ,toxicomanes
- Pneumopathie sous-jacente souvent extensive, abcédée, bilatérale, avec tableau grave et détresse respiratoire

VI. DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

4- Entérobactéries (BGN):

- Escherichia coli, klebsiella, Proteus..
- Résistance aux ATB : traitement en fonction de l'antibiogramme: quinolone, céphalosporine, aminosides

5- Germes anaérobies :

- Bactéroïdes, Fusobacterium, Peptostreptococcus... etc.
- Terrain : mauvais état dentaire, sujet éthylique
- Fétidité de l'épanchement et de l'expectoration.
- Pouvoir nécosant ++

6- Bacille tuberculeux :

- Rarement incriminé, doit être recherché systématiquement.

VII. TRAITEMENT

Traiter l'infection
(Antibiothérapie)

Traitement local
(Evacuer la plèvre)

kinésithérapie

Traiter le terrain

VII. TRAITEMENT

1- Traitement général :

- **Antibiothérapie :** Initialement probabiliste en **IV** : Amoxicilline/acide clavulanique ou (Céphalosporine 3^{ème} G) + Métronidazole
- Elle sera ensuite adaptée selon le résultat des prélèvements bactériologiques.
- D'une durée de 3 à 6 semaine

2- Traitement local :

- Évite le passage à la constriction par pachypleurite.
- Stade de diffusion : ponction avec une aiguille de gros calibre et lavage au sérum physiologique.
- Stade d'enkystement : Drainage après repérage échographique et/ou scannographique et lavage au sérum physiologique.

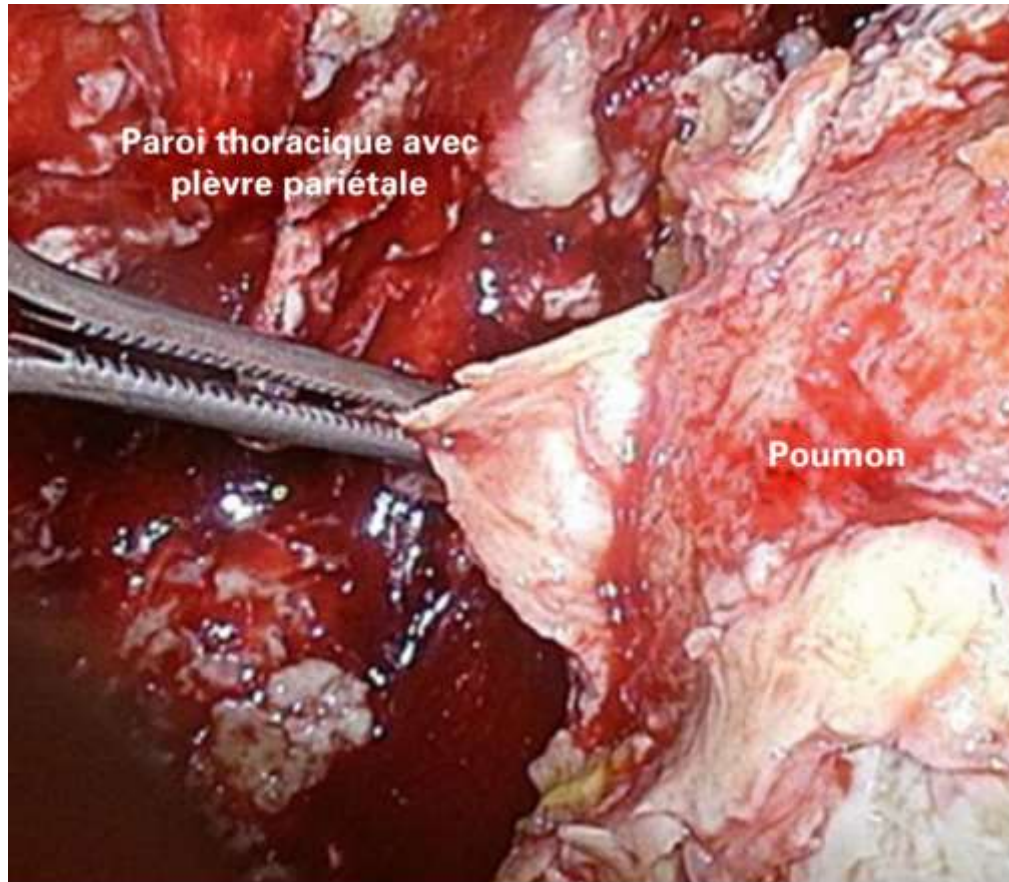
3- Kinésithérapie respiratoire et pleurale :

- A débiter précocement, but faciliter le drainage bronchique + la ré-expansion pulmonaire.

4- Traitement chirurgical:

- Une décortication soit une pleuro-éxerèse (stade III)

Thoracotomie : Décortication pulmonaire



5 -Mesures associées :

- Recherche et éradication d'un foyer infectieux
- Correction des troubles hydro-électrolytiques et nutritionnelles
- Traitement d'une pathologie associée

VIII. EVOLUTION

☐ Evolution favorable :

- Le traitement précoce: évite l'évolution vers l'enkystement.

☐ Evolution défavorable:

- Pachypleurite avec insuffisance respiratoire restrictive
- Des rétractions pleurales
- Bronchectasie
- Des fistules broncho-pleurales.

IV. CONCLUSION

- ❑ La pleurésie purulente est une affection grave survenant chez les sujets fragiles.
- ❑ Leur prise en charge est avant tout hospitalière .
- ❑ Leur traitement préventif repose sur le traitement correct de toute pneumopathie
notamment chez les sujets avec comorbidités